

• 护理园地 •

居家护理干预对阿尔茨海默病患者康复效果的影响

王晓湘, 张 汝, 刘文清, 王 炜, 何 莎, 蔡羚琴, 张一洁, 潘 琴, 李改丽

[关键词] 阿尔茨海默病; 居家护理; 照顾者; 简易智能量表; 日常生活量表

中图分类号 R 473.5 文献标识码 A

文章编号 1004-0188(2014) 01-0085-02 doi: 10.3969/j.issn.1004-0188.2014.01.036

阿尔茨海默病(Alzheimer's disease, AD)是威胁老年人最严重的疾病之一。调查显示,我国 65 岁以上老人 AD 患病率为 5.9%^[1]; AD 发病与年龄呈正相关,每增加 5 岁,AD 发病率增加 1.06 倍^[2]。目前尚无有效的方法逆转 AD 患者的进展性病程,只能采取各种措施减缓痴呆病情的发展,科学规范的生活照顾和干预是延缓病情进展、提高生活质量的重要手段^[3]。居家治疗是现阶段我国大多数 AD 患者主要的照顾方式,但由于大多数照顾者对 AD 相关知识的认识不足,AD 患者的居家治疗还存在许多问题,大多数只给予了一般性的生活照顾。本研究通过比较科学规范的居家护理干预和一般的生活照顾对 AD 患者的延缓病情的作用,为 AD 患者如何进行科学规范的居家照顾,如何建立规范家庭支持系统提供参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象 2011 年 4~6 月采用中国精神障碍分类与诊断标准第三版(CCMD-3),对成都地区的 6 个干休所 800 余名老年人进行 AD 筛查;2011 年 6 月~2012 年 5 月对确诊的 128 例 AD 患者,其中男 76 例,女 52 例,进行为期 1 年的试验研究。试验纳入标准:65 岁以上,男女不限;Hachinski 评分 < 4 分,排除血管性痴呆;汉密尔顿抑郁量表 < 17 分,排除抑郁症。

1.2 分组 按患者入院顺序编号,采用随机数字表,将 128 例随机分为试验组和对照组,所有患者及其家属都充分告知了研究计划,均自愿参加,并签署家属知情同意书。每组各 64 例,两组在性别、年龄、文化程度等一般情况方面比较差异无统计学意义($P > 0.05$)。

1.3 方法 所有患者均由神经内科专科医生处方给药,主要为安理申和美金刚,均坚持服药治疗。对照组只给予一般的社区卫生服务和生活护理,未进行居家护理干预;试验组采用规范的居家护理干预模式进行为期 1 年的规范干预。并在干预开始,干预后 6、12 个月时,由居家护理干预小组对所有患者进行 MMSE 量表、ADL 量表的测评,共 3 次。并在干预前后量化比较照顾者对 AD 相关知识知晓情况。

1.4 居家护理干预具体方法 成立由 1 名神经内科主治医师及 1 名主管护师组成的居家护理干预小组,对试验组照顾

者进行短期的集体培训,主要内容有:AD 的危险因素、并发症、主要的护理方法等。指导照顾者记录患者疾病日志,强调每例患者固定 1 名主要的照顾者(家人或保姆,1 年内不能换人)。编制试验组照顾手册,统一规范居家护理照顾方法。照顾手册主要内容如下:

1.4.1 生活护理 轻中度患者鼓励自行进食,重度患者采取安全的体位缓慢喂食或鼻饲饮食。训练患者每天按时起居,生活规律,白天睡眠时间控制在 1 h 以内。拍背 2~6 次/d,10 min/次。

1.4.2 心理护理 加强与 AD 患者交流,语调、语气要平和,注意使用非语言交流方式,如面部表情及肢体语言;回答问题要尽可能简明扼要。保持患者的情绪稳定,不要随意更改对待患者的行为方式,使患者无所适从。

1.4.3 安全护理 AD 患者的居住环境应舒适安全,光线充足,室内陈设简单、物品摆放固定。严格保管药物,防止误服、错服或漏服。出现药物的不良反应立即停药,并向专科医生汇报。

1.4.4 康复训练 主要包括记忆和思维训练、语言训练、自理能力训练、肢体运动训练。

1.4.5 定期随访 指导小组每 2 个月对试验组患者进行 1 次家访,查看疾病日志,提出建设性意见。同时还要定期对照顾者进行心理疏导,建立长期、固定的照顾者保障支持系统。

1.5 统计学方法 所有数据使用 SPSS 11.0 统计软件进行处理,计量资料用 $\bar{x} \pm s$ 表示,数据间的比较采用 t 检验;计数资料用例和百分率表示,率的比较采用 χ^2 检验, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 试验完成情况 试验过程中,试验组有 2 例、对照组有 3 例由于死亡退出研究(其中 2 例因为脑卒中、3 例因为冠心病死亡),最终完成试验的试验组有 62 例,对照组有 61 例。

2.2 两组不同阶段 MMSE 评分变化 两组在干预前 MMSE 评分比较无统计学差异;干预过程中,不同阶段试验组 MMSE 评分均比对照组高,但只有干预后 12 个月时间点两组评分差异有统计学意义($P < 0.05$);试验组不同时间点比较,干预 6、12 个月时,MMSE 评分较干预前逐渐增高,在干预 12 个月时与干预前比较才有统计学差异($P < 0.05$);对照组不同时间点比较,MMSE 评分逐渐恶化,且间隔 1 年后 MMSE 评分有统计学差异($P < 0.05$)。见表 1。

作者单位:610083 成都,成都军区总医院干部病房(王晓湘,张 汝,王 炜,何 莎,蔡羚琴,张一洁,潘 琴,李改丽),护理部(刘文清)

通讯作者:李改丽,电话:13551284180; E-mail: gaili2409@sina.com

表 1 两组干预不同时间点 MMSE 的变化

组别	n	干预前	干预 6 个月后	干预 12 个月后
试验组	62	14.19 ± 3.21	14.29 ± 4.41	15.98 ± 5.49 ^{①②}
对照组	61	14.12 ± 3.21	13.23 ± 4.49	11.99 ± 6.39 ^①

注:与本组干预前相比,① $P < 0.05$;与同时对照组相比,② $P < 0.05$

2.3 两组不同阶段 ADL 评分变化 两组在干预前 ADL 评分比较无统计学差异;干预过程中不同阶段,试验组 ADL 评分均比对照组低($P < 0.05$);试验组不同时间点比较,干预 6、12 个月后,ADL 评分较干预前逐渐降低,但两两比较无明显统计学差异($P > 0.05$)。对照组不同时间点比较,ADL 评分逐渐恶化,均有统计学差异($P < 0.05$)。见表 2。

表 2 两组干预不同时间点 ADL 的变化

组别	n	干预前	干预 6 个月后	干预 12 个月后
试验组	62	34.14 ± 5.35	33.16 ± 5.29 ^②	32.99 ± 6.35 ^②
对照组	61	34.21 ± 5.74	38.95 ± 6.57 ^①	44.53 ± 7.56 ^①

注:与本组干预前相比,① $P < 0.01$;与同时对照组相比,② $P < 0.05$

2.4 试验组患者家属干预前后对 AD 相关知识知晓情况比较 经过 1 年的护理指导,试验组患者家属对 AD 的危险因素、并发症、护理和治疗方面的知识掌握情况明显好于干预前($P < 0.01$,表 3)。

表 3 患者家属干预前后对 AD 相关知识知晓情况 [n(%)]

时间	n	AD 知识		
		危险因素	并发症	护理和治疗
干预前	64	10(15.63)	8(12.50)	13(20.31)
干预后	62	39(62.90)	43(69.35)	45(72.58)
P 值		<0.01	<0.01	<0.01

3 讨论

随着人类社会老龄化,AD 发病愈来愈高,提高 AD 患者的治疗效果和生活质量有重要的社会意义。目前 AD 主要治疗药物为安理申和美金刚,规范的服药治疗可以延缓患者病情的发展,但目前尚无治疗方法能完全逆转 AD 患者的进展,尚无法根治 AD,而采取各种措施综合治疗,对延缓 AD 患者病情的发展有重要意义。专业、科学的护理是延缓 AD 患者病情和提高其生活质量的重要方法之一^[4-6]。合理科学的护理可以给患者提供心理支持、营养支持,提供智能和运动功能的康复锻炼,避免患者自伤和孤独等,帮助患者实现合理治疗,可以延缓患者病情的发展,减少各种并发症。

由于 AD 患者大多数时间在家里进行治疗和护理,同时社区医疗单位不仅缺乏专业医生和护理人员,而且本身人员数量有限,所以绝大多数患者的照顾者没有受到过专业人员的指导和进行相关知识培训,对 AD 患者的护理仅为简单的生活性照顾,护理质量差强人意^[4];同时也给患者家属和看护者本人造成了很大的负担和困扰。

为了改善长期在家治疗的 AD 患者的护理状况,研究由专业人员进行居家护理干预的效果,本试验按照一定的工作程序,制定了包括一般护理、生活护理、安全护理、心理护理和康复护理等内容的护理培训和护理计划,按照前述方法进行了 1 年的试验。研究结果证实,专业、稳定的居家护理干预可以实现比较科学正规的居家护理,可以增加 AD 患者的 MMSE 评分,明显减低患者的 ADL 评分。表明在同样的药物治疗基础上,科学正规的居家护理可以延缓 AD 患者的病情进展,明显改善患者的日常生活能力。通过长期、稳定、专业的居家护理干预,可以实现比较科学正规的居家护理,减少 AD 患者的住院花费,减慢 AD 患者的病情进展,因而可以减轻 AD 患者的家庭负担和社会负担。同时经过这种模式明显提高了 AD 患者家属对 AD 相关知识的知晓情况,因而能更好地配合患者的治疗,有益于延缓患者的病情发展。短期培训、定期随访指导,加上长期畅通的电话等通信支持系统,也使看护者得到了很大的支持和帮助,减轻了看护者的精神压力,提高了其护理能力。这种专业与非专业相结合的居家护理模式,既可使 AD 患者得到专业、有针对性、持续性的护理服务,又可使患者在熟悉的居家环境中获得周到的生活照顾,增加了患者及家属的安全感及满意度,真正使患者得到实惠。

【参考文献】

- [1] Zhang ZX, Zahner GE, Roman GC, et al. Dementia subtypes in China: prevalence in Beijing, Xi'an, Shanghai, and Chengdu [J]. Arch Neurol, 2005, 62: 447-453.
- [2] 张明园, Robert Katzman, 陈佩俊. 痴呆和阿尔茨海默病发病率 [J]. 中华精神科杂志, 1998, 31(4): 195-198.
- [3] 罗京京, 何玲, 刘国卿. 治疗阿尔茨海默病新药盐酸美金刚 [J]. 中国新药杂志, 2006, 15(9): 742-744.
- [4] 胡荣东. 实施家属健康教育对老年痴呆症患者生活质量的影响 [J]. 解放军护理杂志, 2006, 23(6): 7-9.
- [5] 盛树力. 老年性痴呆及相关疾病 [M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2006: 290.
- [6] 王湘, 邓瑞姣. 老年性痴呆患者护理模式的国内外比较及其启示 [J]. 解放军护理杂志, 2006, 23(1): 44-46.

(收稿日期: 2013-06-18)